Formulario Único de Evaluación Integral
Acta de cierre



Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno (a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Jean Paul Aran Acevedo Zepeda				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	17-Enero-2014	Edad actual	12 años	2 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	José Villarroel 1498, Los Acacios.				Teléfono	958985876	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☐ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☐ lee ☑ escribe ☐				
Escolaridad actual:	7o B.	Establecimiento	Liceo Mixto Los Andes Básico N°1				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 19/03/2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Jocelyn Zepeda	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a) Padre.	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 19/03/2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Marta Fernández	Nombre:
Rol/cargo: Coordinadora PIE ped.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Postular al estudiante al Programa, ya que ha presentado rezago pedagógico.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar)	
Pediatría:	Psicología: Posible TEA.
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía: Concentración
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☒ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

¿Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO | Peso: 49 cm | Talla: 3,850 gr.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

El estudiante tuvo hospitalización durante los primeros 20 días de nacido.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	~~Sí~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración: 1° vez 1 semana – 2° 1 semana y media.					
Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No		Vacunas			~~Sí~~	No

Observaciones:

1° hospitalización 3 días vivo cognatal.

2° " 6 meses. Situacional.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6 meses	Se sienta sólo/a: 8 meses	Camina sin apoyo: 1 año.
Primeras palabras: 9 meses	Primeras frases: 1 año.	Se viste solo/a: 2 años

Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓	Controla esfínter anal Diurno: ___ Nocturno: ✓

Observaciones:

Problemas en la pronunciación de la r.

En su actividad motora general se aprecia: ☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☐ normal ☒ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	~~Sí~~	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LE

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Observaciones:
En general su desarrollo es normal.

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:
No presenta dificultades a nivel auditivo.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones:
Se presenta normalidad respecto al desarrollo del lenguaje.

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Opta por trabajo individual	~~Sí~~	No	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico (repite palabras, sílabas, etc.)	Sí	~~No~~	Movimientos estereotipados (repetitivos)	~~Sí~~	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	~~No~~	Pataletas frecuentes	~~Sí~~	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☑ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☑ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:
Frente a sonidos pitos, Bocinas; en general, se muestra inquieto.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	~~Sí~~	(No)	Trastorno motor	Sí	(No)
Epilepsia	~~Sí~~	(No)	Problema bronco-respiratorio	(Sí)	No
Problemas cardiacos	~~Sí~~	(No)	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	(No)
Paraplejia	~~Sí~~	(No)	Trastorno emocional	Sí	(No)
Pérdida auditiva	~~Sí~~	(No)	Trastorno conductual	(Sí)	No
Pérdida visual	Sí	(No)	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
Virus Sincicial (6meses).
se porta mal en la casa y el colegio

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☑ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☑ inquieto Horas que duerme: 8.30.

☑ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☑ acompañado
(Especifique): En principio con la mamá

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☐ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:
Despierta asostado frente a terrores nocturnos o pesadillas. En general despierta de buen humor.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Mayron Acevedo	Padre	33	4°medio	Conductor de Camiones
2. Jocelyn Zepeda	Madre	38	4°medio	estudiante - Limpieza
3. Tiare Rojas	Hermana	17	Prev.	Estudiante.
4. Maite Acevedo	Hermana	10	5°.	Estudiante.
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LE

Ministerio de Educación

Formulario Único de Evaluación Integral
Acta de cierre



Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante): la Madre tiene hipotiroidismo y hermana mayor hipertiroidismo.
Observaciones: se ha realizado controles respecto al antecedente anterior y se muestra normal.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4ā	Asistió a jardín infantil	Sí	No ✓
N° de colegios en que ha estudiado	3	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios:
→ Cambio de domicilio.
→ Bulling.

Ha repetido curso/s	Sí	No ✓	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	7o B		**Dificultad de aprendizaje**	Sí ✓	No	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí ✓	No
Asiste regularmente	Sí ✓	No	**Asiste con agrado**	Sí	No ✓	**Apoyo familiar en tareas**	Sí ✓	No	**Amigos (as)**	Sí ✓	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) ...se espera...

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☑ otro(s)...regalos.....

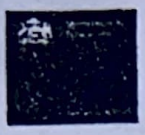
¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales ...Padre cuando puede.

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY



Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

8. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE EN EL ESTABLCIMIENTO

Permanencia

(Señale aquellos antecedentes en relación a la permanencia del estudiante en el establecimiento, por ejemplo, se traslada de una ciudad a otra de manera constante, tiene considerado retirarlo del establecimiento antes que termine el año, etc.):

Si hay intenciones de que el estudiante continue en el establecimiento.

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

El fue a consulta a neurologo
- es muy impulsivo
- tiene toc. (piernas y ojos)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR